

Resumen de Cánceres Urológicos y Digestivos

Cáncer de riñón

Factores de riesgo:

- Tabaquismo
- Obesidad
- Hipertensión arterial
- Exposición a sustancias químicas como cadmio o asbestos
- Antecedentes familiares de cáncer renal

Tipo más común:

Carcinoma de células renales (de células claras)

Clínica:

- Hematuria (sangre en la orina)
- Dolor lumbar o abdominal
- Masa palpable en el flanco
- Pérdida de peso y fiebre sin causa aparente

Diagnóstico y estadificación:

- Ultrasonido renal
- Tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM)
- Biopsia (en algunos casos)
- Clasificación TNM para estadificación

Tratamiento:

- Nefrectomía parcial o radical
- Terapia dirigida (inhibidores de tirosina quinasa)
- Inmunoterapia
- Seguimiento con imágenes

Cáncer de testículo

Factores de riesgo:

- Criptorquidia (testículo no descendido)
- Antecedentes familiares
- Edad joven (15-35 años)
- Síndrome de Klinefelter

Tipo más común:

Seminoma (tipo de tumor germinal)

Clínica:

- Masa testicular indolora
- Sensación de pesadez en el escroto
- Dolor testicular o abdominal (menos común)

Diagnóstico y estadificación:

- Ultrasonido testicular
- Marcadores tumorales: AFP, hCG, LDH
- TC de abdomen/pelvis y tórax para estadificación

Tratamiento:

- Orquiectomía inguinal radical
- Radioterapia (para seminomas)
- Quimioterapia (para tumores no seminomatosos o enfermedad avanzada)
- Seguimiento con marcadores y estudios de imagen

Cáncer de vejiga

Factores de riesgo:

- Tabaquismo (principal factor)
- Exposición a aminas aromáticas (industria textil, caucho)
- Infecciones urinarias crónicas

- Radioterapia previa

Tipo más común:

Carcinoma urotelial (transicional)

Clínica:

- Hematuria macroscópica indolora
- Disuria o urgencia urinaria
- Infecciones urinarias recurrentes

Diagnóstico y estadificación:

- Cistoscopia con biopsia
- Citología urinaria
- TC o RM de pelvis
- Clasificación TNM para estadificación

Tratamiento:

- Resección transuretral de tumor vesical (RTUV)
- Inmunoterapia intravesical con BCG
- Cistectomía radical en enfermedad invasiva
- Quimioterapia sistémica

Cáncer de esófago**Factores de riesgo:**

- Tabaquismo
- Consumo excesivo de alcohol
- Enfermedad por reflujo gastroesofágico
- Esófago de Barrett
- Dieta pobre en frutas y verduras

Tipo más común:

Adenocarcinoma (en países occidentales)

Clínica:

- Disfagia progresiva (sólidos a líquidos)
- Pérdida de peso
- Dolor retroesternal
- Regurgitación o vómito

Diagnóstico y estadificación:

- Endoscopia digestiva alta con biopsia
- Ultrasonido endoscópico
- TC y/o PET para estadificación

Tratamiento:

- Cirugía (esofagectomía)
- Quimiorradioterapia neoadyuvante
- Tratamiento paliativo en enfermedad avanzada

Cáncer de estómago**Factores de riesgo:**

- Infección por *Helicobacter pylori*
- Dieta rica en sal y ahumados
- Tabaquismo
- Antecedentes familiares de cáncer gástrico
- Condiciones precancerosas: gastritis atrófica, metaplasia intestinal

Tipo más común:

Adenocarcinoma gástrico

Clínica:

- Dispepsia persistente
- Saciedad precoz
- Pérdida de peso

- Hematemesis o melena

Diagnóstico y estadificación:

- Endoscopia con biopsia
- TC abdominal
- Laparoscopia diagnóstica (en casos seleccionados)
- Clasificación TNM para estadificación

Tratamiento:

- Gastrectomía parcial o total
- Quimioterapia (adyuvante o neoadyuvante)
- Radioterapia en casos seleccionados
- Tratamiento paliativo si no es operable